·专题报道·

语言康复训练对运动性言语障碍脑卒中患者影响

杨华

天津市蓟州区人民医院神经内科，天津　301900

摘要:目的 言语障碍脑卒中患者生活质量较差,如何改善患者生活质量是脑卒中患者恢复的重要内容。考察语言康复训练对运动性言语障碍脑卒中后吞咽功能障碍患者的复健效果。**方法** 选取 2016 年 7 月—2018 年 3 月天津市蓟州区人民医院收治的运动性言语障碍脑卒中后吞咽功能障碍患者 92 例,随机分为观察组和对照组,每组 46 例。对照组患者给予基础护理以及健康教育,观察组患者在对照组基础上给予语言康复训练。训练内容包括:口部运动训练,正常发声训练,视图读音训练和语言对话训练。比较两组患者的吞咽功能以及语言恢复、生活质量评分情况等。**结果** 观察组患者经语言恢复总有效率为 91.3%,高于对照组的 71.7%,差异有统计学意义(χ^2=5.84,P<0.05)。两组患者的洼田饮水试验评分,差异无统计学意义(P>0.05)。观察组患者社会功能、生理职能、情感职能、精神健康及总体健康评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。**结论** 语言康复训练对运动性言语障碍脑卒中后吞咽功能障碍患者吞咽功能和生活质量具有积极明显的正面影响,值得临床推广应用。

关键词:脑卒中;言语障碍;吞咽功能

中图分类号:R4　**文献标识码:**A　**文章编号:**1003-5052(2023)07-073-03　**DOI:**10.16286/j.1003-5052.2023.07.026

脑卒中属于临床常见疾病,其发病率高、患者预后差[1]。由于脑卒中导致的缺血和缺氧对患者中枢神经系统造成的不良影响，患者在抢救成功后仍有较高概率罹患运动性言语障碍和吞咽功能障碍等并发症[2]。流行病学调查显示,运动性言语障碍和吞咽功能障碍的发生存在一定的正相关，提示两者间存在有内在联系[3]。语言康复训练被证实可有效改善运动性言语障碍患者的语言功能[4]。因此,本研究拟探讨语言康复训练对运动性语言障碍和吞咽功能障碍患者中的应用效果。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取 2016 年 7 月—2018 年 3 月我院收治的运动性言语障碍脑卒中后吞咽功能障碍患者 92 例,随机分为观察组和对照组,每组 46 例。纳入标准：患者均符合汉语失语症检查法的运动性言语障碍诊断标准;洼田饮水试验吞咽功能≥2 级,需>2 次吞咽将水饮完，不伴随声音嘶哑或者呛咳情况，或需≥1 次吞咽将水饮完，伴随声音嘶哑或者呛咳;患者均知情本次研究,同意并经伦理委员会批准。排除标准：昏迷患者;消化道出血患者;因口腔疾病不能经口进食患者；除脑卒中外其他疾病引起的吞咽障碍患者,如重症肌无力,颅内肿瘤等;合并严重的内科疾病患者。对照组女性 17 例,男性 29 例;平均年龄(55.93±6.23)岁;病后就诊时间 1~30 d,平均(12.49±4.99) d;其中脑出血 15 例,脑梗死 31 例。观察组女性 20 例,男性 26 例;平均年龄(55.98±6.26)岁;病后就诊时间 1~29 d,平均(12.47±4.98) d;其中脑出血 13 例,脑梗死 33 例。两组患者一般资料资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2　方法

1.2.1　对照组患者给予常规护理以及健康教育　向患者介绍运动型言语障碍的特点和预后预期，要求患者自主训练语言能力,使其尽量恢复语言功能。

1.2.2　观察组在对照组基础上给予语言康复训练　(1)口部运动训练:若患者存在吞咽障碍或球麻痹、失音情况,指导其进行口部运动。入院后每天进

作者简介:杨华,本科,主管医师,主要从事神经内科治疗工作

通信作者:杨华,E-mail:dream_yangxiaojie@126.com

洗质量的现状调查分析[J].护理实践与研究,2019,16(3):13-15.

[2] 窦红梅,李耀晨.本院消毒供应中心对外来器械管理存在的问题及对策[J].当代护士(中旬刊),2020,27(12):178-179.

[3] 杨蓓,涂丹,毛春华.消毒供应中心手术医疗器械清洗质量影响因素及对策[J].家有孕宝,2020,2(8):198-199.

[4] 张敏,夏丹,李明珠.外来手术器械纳入消毒供应室规范化管理的作用探讨[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(4):186-196.

[5] 高宏,张远玲.规范化操作流程在消毒供应中心精密器械处理中的有效应用[J].中国保健营养,2020,30(30):392-393.

[6] 张文华,闻涛,娄静.规范化清洗消毒对消毒供应中心器械清洗消毒质量的影响[J].齐鲁护理杂志,2020,26(22):129-131.

责任编辑:康金东,校对:苏秋玲

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行口型训练包括伸缩舌、龇牙鼓腮等,2 次/d,5 min/次,连续 3 d。(2)正常发声训练:由训练中依据音节发音难易、音位前后进行训练,以视频记录患者发音时口型及声音,纠正错误的发音。(3)视图读音训练:由护理人员提供以 20 张为一组的图片包括食品、人物和生活用品等于患者生活密切相关的图片,让患者念出图片内容,2 次/d,30 min/次,每周评定。(4)语言对话训练:要求患者回答护理人员简单问题,如年龄、性别和生活对话问题,依据训练进度要求患者逐步增加回答时的语句长度。在训练的过程中,给予患者正向的反馈,并积极地鼓励患者于护理人员沟通,不要担心对错,若发音错误及时进行纠正。对于能发双音节的患者,护理人员启发患者说出相关的词语以及短句,可让患者快速地重复一句话,并配合视频练习。

1.3 观察指标 患者经 3 个月干预后,应用中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表来评估其语言能力恢复情况,提高≥2 个级别为显效;提高 1 个级别为有效;语言能力无变化或降低为无效。采用洼田饮水试验评价患者吞咽功能:以患者安静状态饮用 30 mL 纯净水(30~40 ℃)为标准。Ⅰ级:表示患者可1次饮完且未出现呛咳情况;Ⅱ级:表示患者无呛咳情况,但需要分 2 次饮完 30 mL 纯净水;Ⅲ级:表示患者存在呛咳,且 1 次饮完 30 mL 纯净水;Ⅳ级:表示患者 2 次饮完 30 mL 纯净水,或者饮水过程会总发生呛咳;Ⅴ级:表示患者需要多次饮完 30 mL 纯净水,且出现明显的呛咳情况。两组患者生活质量评估标准:以健康调查简表(SF-36)量表为准,包括 8 个维度(生理功能、生理职能、躯体疼痛、情感职能、活力、社会功能、精神健康及总体健康),评分越高表示生活质量越好。

1.4 统计学处理 采用 SPSS 19.0 软件对数据进行分析,计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示,采用 t 检验,计数资料用 n(%)表示,采用 χ^2 检验,等级资料采用秩和检验,$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者语言功能恢复比较 观察组显效 26 例,有效 16 例,无效 4 例,总有效率为 91.3%(42/46);对照组显效 19 例,有效 14 例,无效 13 例,总有效率为 71.7%(33/46);观察组语言恢复效果高于对照组,差异有统计学意义($\chi^2=5.84$,$P<0.05$)。

2.2 两组患者洼田饮水试验比较 两组患者洼田饮水试验,差异无统计学意义($P>0.05$),见表 1。

表 1 观察组与对照组患者洼田饮水试验比较 [n(%)]

组别	例数	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级	Ⅴ级
对照组	46	19(41.3)	8(17.4)	7(15.2)	7(15.2)	5(10.9)
观察组	46	20(43.5)	9(19.6)	8(17.4)	6(13.0)	3(6.5)
Z 值				0.38		
P 值				>0.05		

2.3 两组患者生活质量评分比较 观察组患者社会功能、生理职能、情感职能、精神健康及总体健康评分高于对照组,差异均有统计学意义($P<0.05$),见表2。

表 2 观察组与对照组患者生活质量评分比较 ($\bar{x}\pm s$,分)

项目	观察组(n=46)	对照组(n=46)	t 值	P 值
社会功能	86.3±7.3	78.4±8.4	4.60	<0.05
生理功能	84.6±6.1	83.9±6.5	0.51	>0.05
生理职能	88.4±6.2	83.3±6.5	3.68	<0.05
情感职能	84.4±7.2	79.3±5.2	3.72	<0.05
活力	82.1±4.5	81.6±6.4	0.22	>0.05
精神健康	81.6±6.3	80.5±5.8	0.92	<0.05
躯体疼痛	80.7±6.7	80.5±5.4	0.16	>0.05
总体健康	87.8±6.5	80.6±5.3	6.24	<0.05

3 讨 论

脑卒中发病急、预后差是影响居民健康的致死性脑血管疾病,危害较大。患者发病后有语言障碍、半身不遂等不良预后的发生。运动性言语障碍是脑卒中后的常见并发症,表现为语言量减少和语法结构缺失,但无音肌瘫痪,其预后差异较大,部分患者可以完全恢复,但部分患者则会丧失语言表达能力[5]。罹患运动性言语障碍的患者不仅语言功能受损,同时还更易并发其他疾病如吞咽功能障碍。因此,积极干预脑卒中后运动性言语功能障碍症状有助于改善脑卒中患者的整体预后。

由于运动性言语障碍的病理过程涉及神经损伤,因此治疗难度较大,临床上以护理干预为主[6-7]。语言康复训练是指通过辅助患者进行语言功能训练促进患者神经细胞突触形成,建立突触链,恢复正常生理职能[8]。证实通过早期的语言康复训练可以有效恢复脑卒中患者的语言功能和沟通能力[9-10]。

本研究显示,观察组患者语言功能恢复疗效明显优于对照组患者,提示在本研究中语言康复训练可以有效改善运动性言语障碍脑卒中并发吞咽功能障碍患者的语言恢复,与已有报道结果相符。其原因可能是长期反复的对患者进行语言相关训练,可以

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

·病例报道·

数字减影与血管造影对子宫动脉造影的诊断价值

杨璐璐

高唐县人民医院CT室，山东　聊城　252800

摘要:目的 探讨分析在子宫动脉造影中应用数字减影技术(DSA)以及 CT 血管造影技术(CTA)的作用,为临床子宫肌瘤的诊断提供依据。**方法** 本次研究对象为高唐县人民医院 2019 年 12 月—2021 年 6 月收治的 70 例单发肌壁间子宫肌瘤患者(共计 140 支子宫动脉),所有患者均接受手术治疗,并根据术后病理检验结果得到确诊。在术前对患者分别采用 DSA 以及 CTA 进行检查,将获取的检查结果与患者确诊结果对比,比较两种检查方式的诊断价值。**结果** CTA 对子宫动脉开口情况的诊断准确率为 85.71%,高于 DSA 的 24.29%,差异有统计学意义(χ^2=106.724,P<0.05)。CTA 对子宫动脉走行角度的的诊断准确率为 97.14%,高于 DSA 的 27.86%,差异有统计学意义(χ^2=143.375,P<0.05)。CTA 对子宫肌瘤供血情况的诊断准确率为 97.14%,高于 DSA 的 70.00%,差异有统计学意义(χ^2=18.781,P<0.05)。**结论** 在子宫动脉造影中应用 CTA 可以更好地分辨患者的子宫动脉走向,更为准确定位患者的子宫动脉开口,为开展治疗提供有效信息,值得临床推广应用。

关键词:子宫动脉造影;数字减影技术;CT 血管造影技术;应用效果

中图分类号:R739.4　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1003-5052(2023)07-075-04　　**DOI:**10.16286/j.1003-5052.2023.07.027

子宫肌瘤作为临床上比较常见的妇科疾病,目前医学界对子宫肌瘤的具体发病原因存在着较多的说法，认为患者的发病是多种因素在共同作用下所引发。该病多发于 30~50 岁女性,如果患者没有症状

作者简介:杨璐璐,本科,主管技师,主要从事影像技术工作

通信作者:杨璐璐,E-mail:gthf8654@163.com

帮助患者重新建立新的语言相关神经信号通路,弥补因脑卒中导致的相关神经通路损伤[8]。同时,在比较两组患者吞咽功能差异后发现,两组患者洼田饮水试验分级比较差异无统计学意义,虽然运动性言语障碍与吞咽功能障碍间存在一定的联系,但单纯对患者进行语言康复训练无法直接改善患者的吞咽功能。观察组患者各项生活质量量表评分均高于对照组,提示语言康复训练可以有效改善并发运动性言语障碍和吞咽功能障碍脑卒中患者的生活质量,其原因可能是由于观察组患者语言功能恢复更优,一方面给予患者更多的康复信心,另一方面增强了患者的沟通、社交能力,从而增加了患者社会功能和生理职能,促进了构建疾病康复行为,使患者康复信心逐渐增强。

综上所述，语言康复训练利于改善运动性言语障碍脑卒中后患者的语言功能，能提高患者的生活质量,值得临床推广应用。

参考文献

[1] Caplan LR，Simon RP，Hassani S. Cerebrovascular disease-stroke[J]. Neurobiology of Brain Disorders(Second Edition)，2023(6):457-476.

[2] Li R，Mukadam N，Kiran S. Functional MRI evidence for reorganization of language networks after stroke [J]. Handbook of Chinical Neurology，2022，30(1):1-2.

[3] Li L，Huang H，Jia Y，et al. Systematic Review and Network Meta-Analysis of Noninvasive Brain Stimulation on Dysphagia after Stroke [J]. Hindawi Limited，2021,63(17):79-84.

[4] 李铭.早期语言康复护理联合手部训练法对脑卒中失语症患者语言功能的干预效果[J].国际病理科学与临床杂志，2021,41(3):645-651.

[5] Noh，Jun SL，Sekwang N，et al. Integrity of arcuate fasciculus is a good predictor of language impairment after subcortical stroke [J]. Journal of neurolinguistics，2021，58(1)：255-259.

[6] Barnett C，Mitchell C，Tyson S. The management of patients with functional stroke：speech and language therapists´ views and experiences[J]. Disability and Rehabilitation，2021(2):1-12.

[7] Francois LRFA. Signatures of brain plasticity supporting language recovery after perinatal arterial ischemic stroke[J]. Brain and language，2021，212(1):66-69.

[8] Mercer E，Sherfey E，Ogbu C，et al. Effects of CPAP on Language Recovery in Post-Stroke Aphasia：A Review of Recent Literature[J]. Brain Sciences，2022，12(3):379-391.

[9] 姜昕伶,刘红.针灸配合康复训练治疗卒中后言语障碍的效果观察[J].养生大世界,2022,12(10):44-45.

[10] 葛胜男,王勇丽,尹敏敏,等.脑性瘫痪并发言语障碍的诊断、评估与康复:基于 WHO-FICs 研究[J].中国康复理论与实践,2022,28(6):637-645.

责任编辑:康金东,校对:苏秋玲

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net